Influence des labos : "Nombreux ont intérêt à ce que le système perdure"

Publié le 10/01/2023 à 19h46 Mis à jour le 11/01/2023 par **Marie Toulemonde**

Introduction et dat des liens Pr Schaffer Administration de l'Urologie

▲ Paul Schaffer est président de l'association Formindep, ODFI

L'association Formindep "pour une formation et une information médicales indépendantes" lutte contre l'influence des intérêts économiques du secteur de la santé. Elle réalise régulièrement un classement des facs de médecine selon leur politique de prévention des conflits d'intérêts et soulignant en novembre dernier "les bons élèves et les timides" des CHU français sur le sujet. Paul Schaffer est président de l'association.

Annonce

Découvrez la résidence Park Avenue, des appartements du T2 au T5 duplex.

Portail immobilier

Ouvrir

Votre classement des CHU en matière de gestion des conflits d'intérêts a été publié en novembre dernier. Parmi les 17 établissements ayant répondu à l'enquête de Formindep, Bordeaux est classé dernier avec seulement 1 point. Avez-vous eu les retours escomptés? Paul Schaffer. Non nous n'avons eu aucun retour de la part des facs. Bordeaux. A priori rien n'a vraiment changé. C'est l'inertie du monde médical Si l'hôpital public a en ce moment d'autres priorités qui peuvent être légitimes, il est étonnant que les nombreux acteurs en son sein ne cherchent rien à ce que le système perdure en l'état.

>>> Retrouvez toute notre enquête sur le poids des labos à l'hôpital

Pour quelles raisons? Pour de nombreux médecins, l'industrie constitue un allié incontournable pour exercer correctement leur carrière. Pour monter en grade par exemple, les publications dans des revues prestigieuses sont importantes et plus on en a mieux c'est. Publish or perish ("publier ou périr") selon l'adage. Les labos ont bien compris comment ils pouvaient tirer part de ce système et proposent par exemple, via des agences spécialisées qu'ils ne rémunèrent, des articles qu'il n'y a plus qu'à signer. Cela rapporte à pas mal de chercheurs. Un gain de temps certain pour les médecins qui acceptent ces pratiques financières qui ne jouent coup de pouce pour leur notoriété.

Il y a une rhétorique du progrès autour de l'innovation qui aidait à convaincre les médecins alors que la science médicale inviterait plutôt à la prudence

On sait par ailleurs qu'une grande partie de la recherche – des essais cliniques sont financés par l'industrie qui garde notamment la main sur les protocoles.

En effet, la majorité des essais cliniques sont financés par les firmes, qui ont accaparé de plus en plus de contrôle et de pouvoir sur les données décennies. La recherche est un des domaines clé car sur la science se basent ensuite de nombreuses décisions politiques. La rémunération de mise sur le marché et l'utilisation des médicaments. Au cœur de tout ça, il y a une rhétorique du progrès autour de l'innovation qui aidait de nombreux médecins alors que la science médicale inviterait plutôt à la prudence. Des nouveaux médicaments lancés sur le marché avec tambours et trompettes sont retirés après quelques années et au final, les rétés progrès thérapeutiques sur une année se comptent sur les doigts de la main. C'est en revanche un argument marketing fort pour vendre des molécules plus chères sur marchés nouveaux aux aussi moins de recul en termes d'effets secondaires.

Au delà du risque sanitaire, c'est un gaspillage d'argent considérable.

On pourrait donc douter de la pertinence d'une partie de la littérature scientifique? Oui, des études sont très chères. Pour Richard Horton, qui fut le rédacteur en chef du Lancet, 50 % des études publiées dans le monde ne seraient pas fiables, soit trop biaisées méthodologiquement, et/ou non reproductibles. Cet été, un scandale sanitaire américain Vioxy Prezal et son équipe ont reçoivent près de 400 critiques médicales que la science a contrédites mais qui perdurent malgré du double gaspillage sanitaire, c'est un gaspillage d'argent considérable.

Y a-t-il des alternatives? Le British Medical Journal a tout récemment publié un appel à l'action pour "plus d'indépendance dans la recherche, l'éducation et les pratiques médicales. Ils listent un ensemble de mesures qui apparaissent comme les plus à mes mêmes fonctions, et peut-être même être plus efficaces en termes de transmission des savoirs pertinents pour les pratiques, comme le soutient Pascale dans son article Refroidissement Continuous Medical Education publié en 2008 dans le BMJ, et de contrôle des dépenses de pratiques financières plus efficaces et moins dépendantes de l'argent des firmes pharmaceutiques pourraient être doute remplir ces